

Сравнительная оценка информативности визуальных методов диагностики колоректального рака

Арзыкулов Ж.А., Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Колоректалды обырдың визуалды диагностикалық тәсілдерінің ақпараттық салыстырмалы бағасы

Ж.Ә.Арзықұлов, Ж.Ж.Жолдыбай, М.С.Садықов

Колоректалды обырды әртүрлі диагностикалық тәсілдермен зерттеу арқылы ісіктің таралу дәрежесін бағалай отырып, қолайлы диагностикалық тәсілдер қолданылды. Колоректалды обырды саластырмалы түрде анықтауда эндоскопиялық зерттеу биопсия алумен қатар, кешенді рентгенологиялық зерттеу, ультрандыбысты зерттеулер ең негізгі минималды алгоритм болып саналады.

Анализ наблюдений позволил определить возможности

Comparative Evaluation Of The Informativeness Of The Visual Methods Of Diagnostics Colorectal Cancer

Arzykulov Zh.A., Zholdybay Zh.Zh., Sadykov M.S.

The analysis of observations made it possible to determine the possibilities of different methods of study in the estimation of the prevalence of tumor process. The carried out observations and their analysis it made possible to manufacture the rational

различных методов исследования в оценке распространенности опухолевого процесса. Проведенные наблюдения и их анализ дал возможность выработать рациональную диагностическую тактику применения диагностических методов при опухолевых поражениях толстой кишки. При этом следует, что эндоскопическое исследование толстой кишки с биопсией, комплексное рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости является тем минимальным диагностическим алгоритмом, который необходим для дифференциальной диагностики колоректального рака.

diagnostic tactics of the application of diagnostic methods with the tumor defeats of thick gut. In this case it follows that an endoscopic study of thick gut with the biopsy, a comprehensive x-ray examination, the ultrasonic the study of the organs of abdominal cavity are that minimum diagnostic algorithm, which is necessary for differential diagnostics of colorectal cancer.

Одной из наиболее сложных, трудоемких и значимых проблем современной медицины является проблема диагностики и лечения заболеваний кишечника. В Республике Казахстан ежегодно выявляется более 2-х тысяч больных раком ободочной и прямой кишки [1,2]. По показателям смертности колоректальный рак занимает соответственно 6 и 7 место.

В настоящее время современная программа исследования для ранней диагностики заболеваний толстой кишки, предусматривает использование как эндоскопических методов, в первую очередь фиброколоноскопии, так и рентгенологических [3,4,5]. Детальное распознавание онкологических заболеваний органов брюшной полости, а также степени распространенности опухолевого процесса, не представляется возможным без применения УЗИ, КТ.

С целью углубленного научного анализа данных клинического, инструментального и лучевых методов обследования больных с онкологическими заболеваниями толстой кишки на различных этапах диагностики и лечения была проведена сравнительная оценка информативности визуальных методов диагностики колоректального рака.

Из данной таблицы 1. следует, что результаты КТ измерений в большинстве случаев соответствовали макроскопическим размерам опухоли. Преуменьшение размеров опухоли при эндоскопическом исследовании и первично – двойном контрастировании объяснялись отсутствием возможности измерить экстраорганный протяженность образования, которая являлась максимальным ее

размером. Кроме того, невозможность продвижения колоноскопа или ректоскопа при стенозирующих опухолях также служила причиной неудачных измерений.

Преувеличение размеров опухоли при первично – двойном контрастировании наблюдалась в тех случаях, когда максимальным был размер опухоли по длиннику и не учитывался феномен проекционного искажения. Ошибочные результаты измерений при трансабдоминальной эхографии были следствием недостаточной визуализации органа из – за большого количества газа в кишечнике.

Как видно из представленных в таблице данных, при эндоскопическом и рентгенологическом исследовании толстой кишки оценка инвазивности роста опухоли была ограничено возможной, даже при группировании стадий Т3 – Т4. Эти методы малоэффективны вследствие невозможности

Таблица 1. Сравнительная эффективность различных методов диагностики в определении максимального размера опухоли толстой кишки (точность до 1 см)

Степень соответствия результатов измерений верифицированным данным	Количество исследований (абс.)							
	ЭИ		РИ		УЗИ		КТ	
	абс.	% ± m	абс.	% ± m	абс.	% ± m	абс.	% ± m
С о в п а д е н и е размеров	324	81,2±2,1	342	85,7±1,9	352	88,2±1,7	391	97,9 ± 0,7
Преувеличение размеров	19	4,8±5,0	24	6,0±4,9	16	4,0±5,0	2	0,5 ± 7,0
Преуменьшение размеров	30	7,5±4,9	15	3,8±5,1	14	3,5±4,5	2	0,5 ± 7,0
О т с у т с т в и е возможности измерить опухоль	26	6,5±4,9	18	4,5±5,0	17	4,3±5,0	4	1,0 ± 5,7
Всего исследований:	399	100	399	100	399	100	399	100

Таблица 2. Сравнительная эффективность диагностических методов в определении глубины инвазии рака толстой кишки

Хар-ка опухоли TNM	Кол – во случаев (абс.)				Оценка метода		
	ИП	ЛО	ЛП	ИО	Т	Ч	С
Первично – двойное контрастирование толстой кишки							
T3 – T4	243	88	66	2	0,62	0,73	0,14
% ± m	60,9±3,1	22,1±4,4	16,5±4,6	0,5±7,0			
Эндоскопическое исследование толстой кишки							
T3 – T4	236	83	67	13	0,58	0,70	0,11
% ± m	59,1±3,2	20,8±4,5	16,8±4,6	3,3±5,1			
Трансабдоминальная эхография							
T3	252	24	18	105	0,90	0,69	0,92
% ± m	63,2±3,0	6,0±4,9	4,5±5,0	26,3±4,3			
T4	10	25	24	340	0,80	0,78	0,81
% ± m	2,5±5,2	6,3±4,9	6,0±4,9	85,2±1,9			
Компьютерная томография							
T3	337	6	8	48	0,97	0,98	0,87
% ± m	84,5±1,9	1,5±5,4	2,0±5,3	12,0±4,7			
T4	12	3	6	378	0,98	0,84	0,99
% ± m	3,0±5,1	0,8±6,3	1,5±5,4	94,7±1,1			

оценки внекишечного роста опухоли и поэтому представляли значительное количество ошибочных результатов.

Возможности КТ более информативны, по сравнению с ПДК и УЗИ в определении размеров опухоли по длиннику и поперечнику, измерении толщины пораженной стенки, а также протяженности опухоли по отношению к окружности кишки. Измерения проводили как по аксиальным срезам, выполненным на уровне опухоли, так и по реконструктивным изображениям необходимого сечения отрезка кишки, пораженного опухолью.

Анализ наблюдений позволил определить возможности различных методов исследования в оценке распространенности опухолевого процесса. Проведенные наблюдения и их анализ дал возможность выработать рациональную диагностическую тактику применения диагностических методов при злокачественных и доброкачественных поражениях толстой кишки. При этом следует, что эндоскопическое исследование толстой кишки с биопсией, комплексное рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости

является тем минимальным диагностическим алгоритмом, который необходим для дифференциальной диагностики колоректального рака.

Эндоскопическое исследование рекомендуется в качестве основного метода диагностики в скрининговой программе раннего выявления колоректального рака.

Ультразвуковое исследование толстой кишки выполняется после уточнения локализации зоны обструкции с помощью эндоскопического или рентгенологического методов.

Анализируя достоинства и недостатки клинических и инструментальных методов диагностики колоректального рака, можно сделать вывод, что ни один из них не является абсолютно точным. Только комплексное использование в определенной последователь-

ности традиционных рентгенологических, ультразвуковых и КТ методов диагностики в состоянии преодолеть ограничения классических приемов обследования пациентов.

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинев С.И. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008 г. (статистические материалы). - Алматы, 2009. - 99 с.
2. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинев С.И., и др. // Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009г. – Алматы, 2010. - 108с.
3. Перевозников А.И. Возможности колоноскопии в диагностике причин толстокишечной непроходимости: автореф. дис. канд. мед. наук. - М., 1999. - 25с.
4. Кузьмин-Крутецкий М.И. Колоноскопия в диагностике и лечении хирургических заболеваний толстой кишки: автореф. дис. д-ра мед. наук. - СПб, 1998.
5. Наврузов С.Н., Абдужаппаров С.Б., Ососков А.В. Роль и значение рентгендиагностики при онкологии аноректальной зоны // Мат. VI съезда онкологов и радиологов стран СНГ. - Душанбе, 2010. - С. 88.